

ENGENHARIA DE REQUISITOS E MAPEAMENTO DE PROCESSOS: ESTUDO DE CASO CLÍNICA VIDA+ SAÚDE

Curso: Engenharia de Software

Disciplina: Engenharia de Requisitos

Modalidade: Trabalho em Grupo

1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO DO TRABALHO

Este relatório apresenta os resultados parciais desenvolvidos para a análise de processos de negócio da Clínica Vida+ Saúde. O objetivo deste trabalho é aplicar os conceitos de Engenharia de Requisitos e Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) a um estudo de caso real, identificando stakeholders, compreendendo o fluxo de atividades, levantando regras de negócio, analisando problemas e modelando tanto o processo atual (AS-IS) quanto a proposta do processo futuro (TO-BE).

2. ESTUDO DE CASO: CLÍNICA VIDA+ SAÚDE

A Clínica Vida+ Saúde é uma clínica médica de médio porte que atende pacientes de diversas especialidades. Atualmente, o processo de atendimento é realizado de maneira parcialmente manual, por telefone, WhatsApp ou presencialmente.

Quando o paciente solicita uma consulta, a recepcionista verifica a agenda dos médicos em uma planilha local. Como cada recepcionista mantém seus próprios registros e as informações não são atualizadas imediatamente, ocorrem sérios conflitos de horários e duplicidade de dados cadastrais. Além disso, a clínica enfrenta problemas com falta de confirmação de consultas, ausência de lembretes automáticos e dificuldades na gestão de alterações de agenda e cancelamentos.

A direção da clínica deseja implantar um Sistema de Gestão de Atendimento e Agendamento para centralizar as informações e otimizar o fluxo de atendimento.

3. ETAPA 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Qual é o nome do processo?

Processo de Atendimento e Agendamento de Consultas da Clínica.

2. Qual é o objetivo do processo?

Realizar o agendamento, atendimento e acompanhamento das consultas de forma organizada.

3. **Quem é o cliente do processo?**

O paciente.

4. **Quem executa as atividades?**

Recepcionistas, médicos, pacientes e o sistema.

5. **Quem gerencia o processo?**

A gestão da clínica.

6. **Qual evento inicia o processo?**

A solicitação de uma consulta.

7. **Qual evento encerra o processo?**

Quando a consulta é realizada e o atendimento é registrado pelo médico.

8. **Qual valor é entregue ao cliente?**

Um atendimento médico organizado e adequado, com facilidade para realizar o agendamento.

4. ETAPA 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS

Tabela 1 – *Identificação dos Stakeholders do Processo*

Stakeholder	Interesse no Processo	Participação	Necessidades
Paciente	Consumo do serviço	Usuário final	Agendamento de consultas facilitado
Recepcionista	Organização das consultas	Usuário final	Agendar e verificar clientes com rapidez
Médico	Realizar as consultas	Usuário final	Agendamentos com horários corretos e prontuários fáceis
Gerente	Monitorar fluxo do negócio e da equipe	Validador	Análise de satisfação dos clientes e dos funcionários
Direção	Análise de	Validador /	Análise de dados da

	rentabilidade / gastos	Aprovador	empresa
Equipe de TI	Garantir funcionamento limpo do programa	Gerenciador	Sistemas para reparo e gerenciamento do programa facilitado

5. ETAPA 3 – ANÁLISE DO PROCESSO ATUAL (MAPEAMENTO)

Quem?

- **Quem é o cliente?**
O paciente.
- **Quem executa as atividades?**
As recepcionistas e os médicos.
- **Quem gerencia?**
A direção da clínica (gestão estratégica), as recepcionistas (operação e fluxo) e os médicos (agenda e atendimento clínico).
- **Quem fornece informações?**
O paciente (dados pessoais e requisição de horário) e os médicos (disponibilidade de horário).
- **Quem participa das decisões?**
A direção e os médicos; as recepcionistas são apenas mediadoras.

O quê?

- **Quais são as entradas?**
Solicitação de agendamento de consulta, dados cadastrais do paciente e disponibilidade dos médicos (agenda).
- **Quais são as saídas?**
Agendamento da consulta, atendimento médico registrado e prontuários médicos.
- **Quais são os recursos utilizados?**
Equipe de recepção, corpo médico, infraestrutura física da clínica e canais de comunicação cibernética.
- **Quais ferramentas são utilizadas?**
Planilhas eletrônicas individualizadas e um sistema para registros médicos após consultas.
- **Quais são os problemas?**
Conflitos de horário, duplicidade de dados, falta de integração entre dados de diferentes

entidades, perda de agendamentos informados pelo WhatsApp, alto índice de ausência nas consultas e comunicação manual dificultada.

- **Quais são os pontos positivos?**

A pluralidade de canais de contato com o paciente e a oferta de diversas especialidades médicas.

- **Quais indicadores poderiam ser utilizados?**

Quantidade de consultas médicas realizadas (semanalmente, mensalmente), quantidade de cancelamentos (e quanto esse montante representa em porcentagem em relação aos agendamentos), tempo médio de atendimento (gestão de agenda) e taxa de ocupação da agenda.

Quando?

- **Quando o processo começa?**

Na requisição de consulta pelo paciente por meio de algum contato.

- **Quando as atividades são executadas?**

Continuamente, durante o funcionamento da clínica e, consequentemente, no momento da consulta médica.

- **Quando o processo termina?**

Depois do registro de atendimento no sistema pelo médico (ou pela recepcionista, em caso de cancelamento).

Onde?

- **Onde o processo é iniciado?**

No contato remoto ou na recepção presencial da clínica.

- **Onde as atividades são executadas?**

Na recepção e consultórios.

- **Onde as informações são registradas?**

Nas planilhas individuais mantidas pelo recepcionista e no sistema integrado utilizado pelos médicos.

Por quê?

- **Por que o processo existe?**

Organização de demanda e viabilização de prestação de serviços.

- **Qual valor ele entrega ao paciente?**

Acesso ao cuidado à saúde e organização para atendimento médico.

- **Qual valor ele entrega para a clínica?**

Estrutura operacional para gerar lucro e otimização da capacidade médica.

Como?

- **Como o processo é executado atualmente?**

De forma parcialmente manual e descentralizada. A recepcionista atende o paciente, consulta sua planilha pessoal, registra os dados e marca o horário.

- **Como as informações são registradas?**

Cada recepcionista insere os dados diretamente em sua própria planilha de controle, sem sincronização imediata com as demais.

- **Como ocorre a comunicação com o paciente?**

Por telefone ou WhatsApp, sem envio de lembretes automáticos.

- **Como são tratados os cancelamentos?**

A recepcionista altera a planilha manualmente e precisa buscar ativamente outro paciente para preencher a vaga liberada.

- **Como são tratadas as alterações de agenda?**

A recepcionista liga ou envia mensagens individualmente para cada paciente afetado pela mudança do médico.

6. ETAPA 4 – IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

Tabela 2 – Atividades Adicionais do Processo

Atividade	Responsável	Entrada	Saída	Regra
Cancelamento de consulta	Paciente / Recepcionista	Solicitação do cancelamento	Modificação da consulta para cancelada	Mínimo de 24 horas para não ter taxa de cancelamento
Prontuário automático	Sistema	Check-in do paciente	Prontuário e dados do paciente diretamente para o médico	Prontuário só aparecerá para o médico caso o paciente já tenha feito o check-in
Reagendamento automático	Médico / Sistema	Paciente com necessidade de acompanhamento contínuo	Paciente com consulta agendada e preferência	Paciente com necessidade de retorno tem preferência na lista de consultas, com o sistema já deixando

				avisado previamente
Reagendamento	Recepcionista	Paciente entra em contato para mudar a data	Recepcionista altera a data para quando for possível	Mínimo de 24 horas para não ter taxa de cancelamento

7. ETAPA 5 – REGRAS DE NEGÓCIO

Tabela 3 – Matriz de Regras de Negócio

Código	Regra de Negócio	Origem
RN01	Prontuário automático para o médico após o check-in	Sistema
RN02	Agendamento automático de pacientes que necessitam de retorno	Sistema / Médico
RN03	Para cancelamento ou reagendamento necessidade de 24 horas de antecedência ou multa	Direção / Gerente
RN04	Confirmação de consulta obrigatória dentro das últimas 24 horas antes da mesma	Recepcionista
RN05	Paciente com mais de 30 minutos de atraso terão seu horário trocado com o paciente seguinte	Recepcionista
RN06	Pacientes com mais de 1 hora de atraso sem aviso prévio terão sua consulta	Recepcionista

	cancelada	
RN07	Consultas que necessitem de prontuários externos os mesmos terão de ser mandados antes do check-in do paciente	Direção
RN08	No agendamento da consulta é necessário selecionar qual o serviço que o paciente necessita a fim de estimar um tempo de consulta, com o sistema bloqueando agendamentos de consultas muito próximas a outras que sejam demoradas	Equipe de T.I
RN09	O sistema não deve permitir a finalização da consulta sem uma documentação do médico sobre a mesma	Direção
RN10	Pacientes com necessidades especiais ou menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável legal	Direção

8. ETAPA 6 – IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS

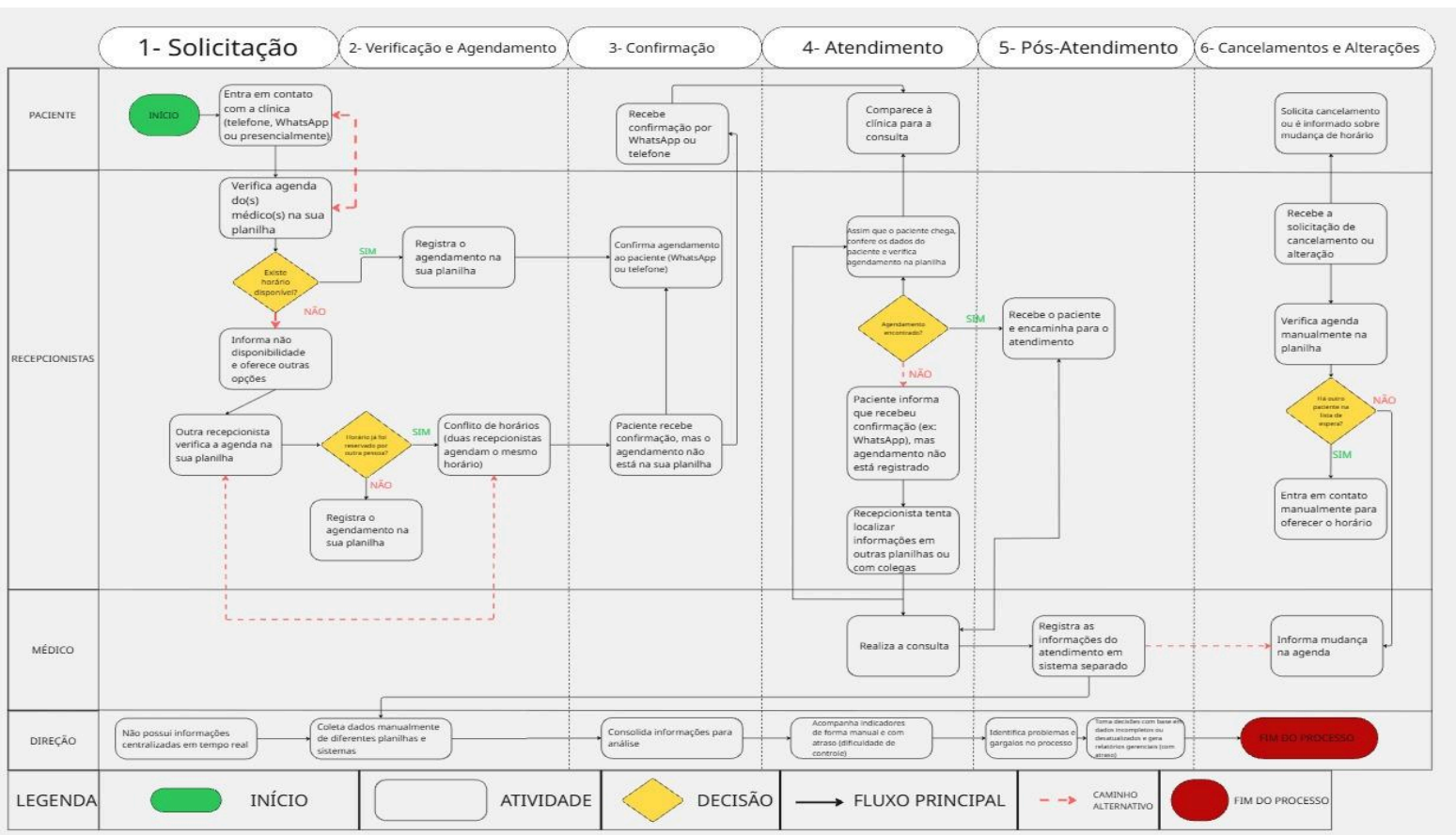
Tabela 4 – Levantamento dos Problemas Existentes

Problema	Causa provável	Impacto	Prioridade
Conflito de horários	Agendamento simultâneo por	Cancelamento de última hora,	 Alta

	vários recepcionistas.	retrabalho ou insatisfação do cliente.	
Retrabalho	Necessidade de inserir os mesmos dados várias vezes.	Perda de tempo e aumento da chance de erros.	● Média
Informações descentralizadas	Dados dispersos em papéis, planilhas locais.	Problema na busca por histórico, risco de erro no diagnóstico.	● Alta
Falha de confirmação de agendamentos	Falta de um padrão para confirmar consultas.	Pacientes podem esquecer ou não comparecer.	● Alta
Falta de lembretes automáticos	O sistema não envia notificações aos pacientes.	Aumento de faltas.	● Média
Cadastro duplicado de pacientes	Falta de validação para ver se o paciente já está cadastrado.	Informações duplicadas e dificuldade para consultar o histórico.	● Média
Dificuldade para gerar relatórios	Falta de ferramentas que organizem os dados.	Demora de análise das informações clínicas.	● Baixa
Dificuldade para alterar dados do paciente	Processo de atualização feito manualmente.	Pequena demora para manter os dados atualizados.	● Baixa

9. ETAPA 7 – MODELAGEM AS-IS

A modelagem do processo atual (AS-IS) mapeia o fluxo descontinuado e parcialmente manual da clínica, destacando o fluxo de solicitação via recepcionistas com checagem de planilhas individuais e sem sincronia.



(A representação gráfica do modelo AS-IS deve ser anexada ou acessada via diagrama correspondente).

10. ETAPA 8 – PROPOSTA DE MELHORIAS

Tabela 5 – Proposta de Melhorias para o Processo

Problema	Melhoria proposta	Benefício esperado
Conflito de horários	Agenda centralizada	Redução de conflitos
Cadastro duplicado	Cadastro único	Redução de retrabalho
Falta de lembretes	Envio automático	Redução de faltas

11. ETAPA 9 – MODELAGEM TO-BE

O processo futuro (TO-BE) estrutura o fluxo otimizado com o uso do novo sistema centralizado. A automação abrange desde a verificação de cadastro e disponibilidade da agenda em tempo real, envio automático de confirmações/lembretes, realização de check-in integrado e disponibilização do prontuário médico até a geração automática de relatórios e indicadores para a gestão.

